内科学含诊断学 风湿系统疾病

核心精讲·系统性红斑狼疮

（性感认识：脸上长斑口腔烂、浆膜关节会发炎…）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

细胞核中有DNA、组蛋白、非组蛋白作为抗原
抗原与自身抗体结合后，形成抗原抗体复合物
免疫复合物沉积在血管壁引起的血管炎为ⅢⅡ型变态反应
该血管炎遍及全身，导致各个组织由于缺血坏死发生疾病

一、自身抗体

	敏感性	特异性
ANA	最高	X
dsDNA	很高	很高
Sm	X	最高

（一）抗核抗体谱

1.抗核抗体 **ANA**：**筛查（敏感性最高）**特异性差（基本上弥漫性结缔组织病都有抗核抗体阳性）
诊断疾病的角度-敏感性很高对疾病不会漏诊，特异性很高对疾病不会误诊

纤溶标志物　室壁张力↑→BNP(+)
排除诊断（敏感性很高）：①D-二聚体正常排除急性肺血栓栓塞 ②BNP 正常基本排除心衰 ③ANA 阴性排除 SLE
阳性不能确诊
阴性可以排除
风湿免疫疾病大都慢性，处于缓解状态
SLE可因紫外线进入疾病活动期

2.抗双链 **dsDNA** 抗体（**标记**）：**确诊和判断活动性最佳**，与**狼疮肾**相关
敏感性、特异性都高

《病理》：肾小球中狼疮小体/苏木素小体（被挤出胞体的细胞核）
最具病理诊断特征

3.抗可提取核抗原 **ENA** 抗体谱（血沉 ESR）

Sm（**标记**）	**早期或不典型**者诊断或回顾性诊断（**特异性最高**）绑起来最特别
SSA（Ro）	平滑肌受累、**继发干燥综合征**、光过敏、**皮损**、白细胞↓、**血管炎**、**新生儿狼疮**（心脏传导阻滞等）平滑干光白眼狼
SSB（La）	**继发干燥综合征**
RNP	**雷诺现象**、肺动脉高压（混混（混合结缔组织病）人品被高空雷击）
rRNP（抗核糖体抗体）	**神经精神**狼疮 NPLE

核糖体 ribosome robot
雷诺现象：多发性骨髓瘤（高黏滞综合征中部分IM蛋白为冷球蛋白）
系统性硬化症
SLE(RNP)

（二）抗磷脂抗体 肺栓塞危险因素之一

①**狼疮抗凝物**（梅毒血清试验假阳性）、抗**心磷脂**抗体、抗 β_2 **糖蛋白**抗体（β_2-**GPI**）糖蛋白 gua pi
②血管**血栓形成**（可发生在**所有血管**）、习惯性自发性**流产**、**血小板↓**
都有血小板
（没狼心瓜皮哎/GPI、血栓流产）
破坏、消耗plt
胎盘由于血栓形成导致胎儿缺血引起流产
抗磷脂抗体与血小板提供磷脂表面结合，激活血小板，促进广泛血栓形成
同时导致血小板被破坏、消耗，因此血小板↓
虽然血小板↓但不可以输血小板

（三）抗组织细胞抗体

攻击红细胞抗体一定是IgG
①**抗红细胞抗体（Coombs 试验）**、抗血小板抗体、抗神经元抗体
②活动期可伴一系或全血细胞↓、**网织红细胞↑**溶血
病例题中出现全血细胞↓/网织红↑
既可能是血液系统疾病
也可能是风湿系统疾病

Coombs试验：温抗体自免溶、Evans综合征、淋巴瘤、慢淋、抗磷脂综合征、SLE、类风湿、新生儿溶血、某些药物、病毒等
①+SLE ②+淋巴瘤 ③+ITP(Evans综合征)

（四）其他

温医的ooo宝宝红蜂病毒来吃药
部分可有类风湿因子 RF、少数可有抗中性粒细胞胞质抗体 ANCA
特异性不高

易致肾脏损害-苏木素小体（肾脏穿刺活检-满堂亮）
典型的ⅢⅡ型变态反应，抗原抗体复合物易沉积在肾小球（入球口径>出球口径）

可能可能最可能：青年**女**性多见，**发热**（低中热常见）、**颊部蝶形/盘状红斑**、**蛋白尿**、一系或全血细胞↓/**Ret↑**/**Coombs** 试验等**多系统损害**
狼疮带：真皮浅表部出现免疫复合物沉积
SLE可继发ⅡⅡ型急进性肾炎（免疫复合物型）
SLE是血管炎，形成抗原抗体
免疫复合物时消耗了大量补体
免疫球蛋白↑（荡秋千）

注意：多数指标都与病情活动性相关，如抗 dsDNA 抗体↑、补体↓、脑脊液 CSF 变化、蛋白尿↑、ESR↑、C 反应蛋白 CRP↑，以抗 dsDNA 抗体判断活动性最佳。而常考的与活动性**无**关的指标是 **ANA、Sm、SSA、SSB**（ASSS）
病理：内胚窦瘤ASSS（AFP、疏网状结构、S-D小体、嗜酸性小体）

血小板↓ VS 类风湿活动期血小板↑